

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio de Alto Riesgo Obstétrico

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	33 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Profesora
Fecha de elaboración:	08/04/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G3 P2 (1 parto vaginal 2018, 1 cesárea segmentaria 2021). Antecedente quirúrgico uterino sin complicaciones.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	26/09/2025
FPP:	03/07/2026
EG actual (por FUM):	31 semanas
Controles prenatales:	6 al momento
Diagnóstico:	Placenta previa total

Paciente refiere episodios intermitentes de sangrado vaginal escaso en últimas 2 semanas. Niega dolor abdominal, contracciones o pérdida de líquido. Movimientos fetales presentes y normales.

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (08/04/2026)

Feto único, vivo, presentación cefálica. Peso fetal estimado 1,680 g. Placenta de inserción anterior cubriendo totalmente el orificio cervical interno — placenta previa total confirmada. ILA dentro de rango normal. Anatomía fetal sin malformaciones evidentes.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 116/72 mmHg. FC 84 lpm. T° 36.6°C. Peso 68.5 kg. AU 30 cm. LCF 144 lpm. Sin signos de sangrado activo al momento. Tacto vaginal diferido por dx de placenta previa.

LABORATORIOS (06/04/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	10.5	g/dL	Anemia leve gestacional
Hematocrito	32.0	%	Límitrofe bajo
Plaquetas	245000	/mm ³	Normal
Glucosa basal	85	mg/dL	Normal
Tipo sanguíneo	O Rh+	—	Confirmado

PLAN

1. Reposo relativo en domicilio. Evitar esfuerzo físico y relaciones sexuales. 2. Control prenatal semanal con monitoreo de sangrado y bienestar fetal. 3. Eco obstétrica de seguimiento cada 2-3 semanas. 4. Hierro elemental 60 mg VO c/24 h. 5. Cesárea programada a las 37 semanas según protocolo institucional. 6. Ingreso inmediato ante sangrado moderado-severo o trabajo de parto.